

Le système de santé

Cours de Politique économique

Raul Sampognaro

raul.sampognaro@sciencespo.fr

OFCE, Sciences Po Paris

vendredi 10 octobre 2025

» Le deuxième plus grand poste de la dépense publique

10 premiers postes de la dépense pub. par fonction		
Niveau (2023)		
Rang	Poste COFOG	Dép. (en pts. de PIB)
1	10.2 - Vieillesse	13.0
2	07.3 - Services hospitaliers	3.7
3	07.2 - Services ambulatoires	3.1
4	10.1 - Maladie et invalidité	2.8
5	10.4 - Famille et enfants	2.3
6	04.5 - Transports	2.2
7	09.2 - Enseignement secondaire	2.2
8	01.3 - Services généraux	1.9
9	01.7 - Opérations concernant la dette publique	1.8
10	10.5 - Chômage	1.6
Source: Insee		

» Parmi les postes le plus dynamiques depuis 1995

10 premiers postes de la dépense pub. par fonction			
Evolution (1995-2023)			
Rang	Poste COFOG	Dép. (en pts. de PIB)	Δ Dép. pub (en pts de PIB)
1.0	10.2 - Vieillesse	13.0	2.0
2.0	07.2 - Services ambulatoires	3.1	0.8
3.0	04.3 - Combustibles et énergie	0.9	0.6
4.0	07.1 - Produits, appareils et matériels médicaux	1.4	0.6
5.0	07.3 - Services hospitaliers	3.7	0.4
6.0	04.1 - Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi	1.5	0.4
7.0	10.7 - Exclusion sociale n.c.a.	1.3	0.3
8.0	05.1 - Gestion des déchets	0.5	0.3
9.0	08.1 - Services récréatifs et sportifs	0.6	0.2
10.0	08.2 - Services culturels	0.6	0.2
Source: Insee			

» Une des plus importantes branches de l'économie (en termes de VA)

Part de la VA de la branche dans la VA totale française

Année 2023

Branche	VA (en pts de la VA totale)
Activités immobilières	14.6
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles	9.7
Administration publique	7.5
Activités de services administratifs et de soutien	6.1
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques	5.8
Activités pour la santé humaine	5.7
Construction	5.7
Enseignement	5.2
Transports et entreposage	4.5
Activités informatiques et services d'information	3.3
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement	2.9

Source: Insee. Comptes annuel de branche.

» Une des plus importantes branches de l'économie (en termes d'emploi)

Part de la VA de la branche dans la VA totale française

Année 2023

Branche	VA (en pts de la VA totale)
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles	12.3
Activités de services administratifs et de soutien	8.4
Administration publique	8.1
Activités pour la santé humaine	7.1
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement	7.0
Enseignement	6.8
Construction	6.7
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques	5.3
Transports et entreposage	5.1
Hébergement et restauration	4.7
Autres activités de services	3.3

Source: Insee. Comptes annuel de branche.

» Le choix d'un système obligatoire

Dépenses en santé

En pts. de PIB



» Pourquoi des systèmes obligatoires ?

1. **Externalités:** maladies infectieuses, vaccination, etc. Démultipliées si les contraintes financières poussent les agents à renoncer aux soins.
2. **Asymétries d'information:** sélection adverse peut éliminer la rentabilité d'assurer la population
3. **Concurrence imparfaite:** rôle de la R&D génère des monopoles et diminue la capacité à organiser un marché concurrentiel. On peut aussi penser au coût de la formation des professionnels de la santé.

» Un peu d'histoire: les bases de la Sécu sont posées dès le 19^e siècle

- **1893**: assistance médicale gratuite pour les plus pauvres. Le reste de la population devait s'autoassurer (mutuelle ou assurance professionnelle).
- **1928-1930**: lois d'assurances sociales. Adhésion à une assurance maladie est rendu obligatoire pour les salariés (sous un certain seuil). Volonté de contenir les dépenses publiques.

Toutefois les médecins libéraux souhaitent garder le contrôle sur leurs honoraires. En outre les mutuelles refusent l'assurance unique

*Des caisses départementales sont créées et l'affiliation est obligatoire pour les salariés non couverts par ailleurs. Les tarifs de remboursement (**indicatifs**) sont négociés à l'échelle locale et négociée. Dès 1928, un ticket modérateur fixe la part de la consultation non remboursable par la caisse locale.*

Dans les faits le *reste à charge* était supérieur au ticket modérateur.

- **1945**: création de la Sécurité Sociale (maintien du système de caisses départementales). Désormais **tous les salariés (et leurs familles)** sont affiliés obligatoirement.

» Un peu d'histoire: la Sécurité sociale se généralise en dehors du salariat

Ne pas oublier l'extension du salariat

Sans changement réglementaire les *Trente glorieuses* se matérialisent par la baisse de l'emploi agricole (largement indépendant) et le développement de l'emploi salarié féminin.

Généralisation progressive en dehors du salariat

- **1947**: extension aux étudiants
- **1960**: inclusion des agriculteurs
- **1966**: artisans et commerçants

⇒ la généralisation de l'assurance maladie justifie en grande partie la création de la *contribution sociale généralisée (CSG)* pour un financement de la Sécurité Sociale qui ne repose pas exclusivement sur les cotisations sociales.

» Un peu d'histoire: l'universalisation accomplie

- **2000**: création de la *couverture maladie universelle (CMU)* qui garantit l'affiliation à l'assurance maladie pour les personnes sans ressources. Il assure aussi une complémentaire santé.
- **2016**: la *protection universelle maladie (Puma)* consacre le fait que toute personne travaillant ou résidant régulièrement en France est affilié **de droit** à l'assurance maladie obligatoire. Les personnes en situation irrégulière relèvent de l'*aide médicale d'Etat (AME)*

» Les prestations de l'assurance maladie

Deux types principales de prestations

1. **Remboursement de frais de santé.** Prise en charge (totale ou partielle) des consultations, hospitalisations, transport sanitaire, médicaments).
2. **Indemnités journalières.** 50 % du salaire journalier de base pour les personnes en arrêt maladie ou en maladie professionnelle. L'employeur peut compléter jusqu'à 90 % selon les conventions collectives qui s'appliquent.

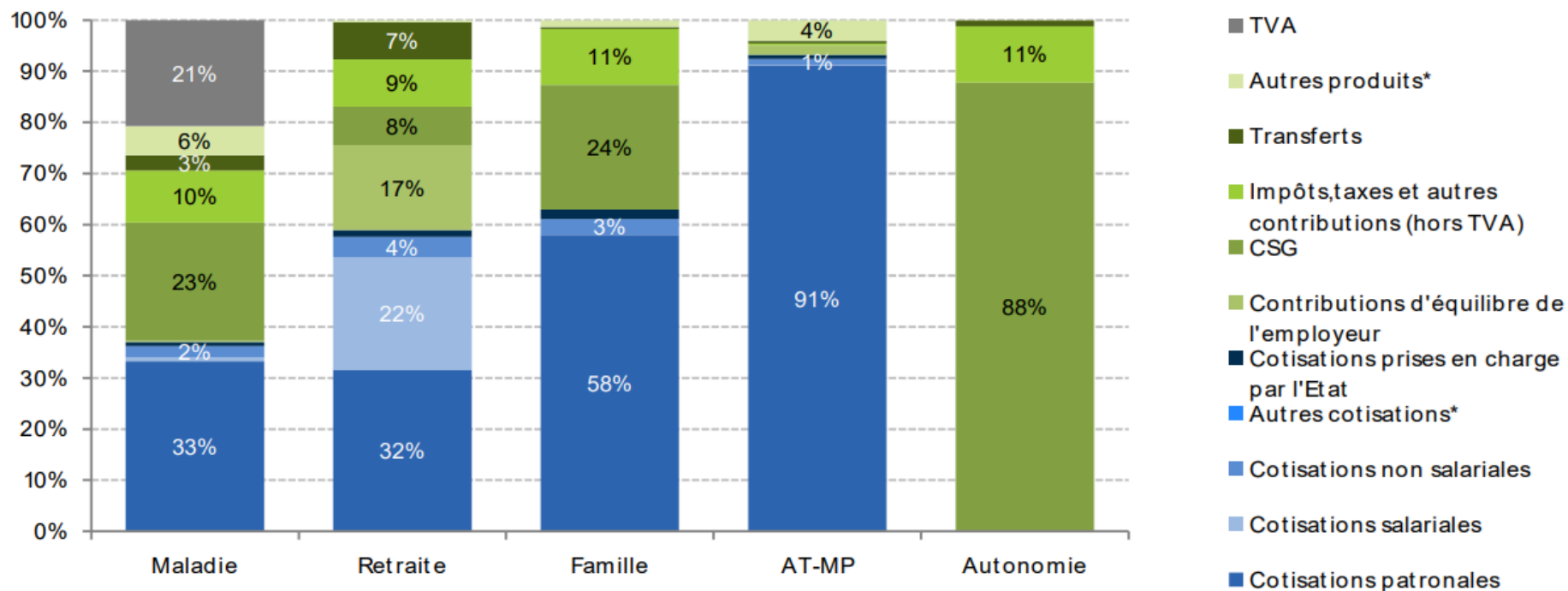
Quelques cas particuliers

1. Les **congés maternité** sont gérés par l'assurance maladie mais dans les comptes de la protection sociale sont enregistrés dans le «risque» famille.
2. les soins et IJ liés à des **accidents de travail ou à des maladies professionnelles handicapantes** sont financés par la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) qui prélève des cotisations spécifiques aux employeurs.

En 2024, les prestations liées aux frais de santé (y compris maternité) s'établissaient à **232 milliards d'euros** (dont 15 milliards d'IJ y compris maternité et paternité).

» Les ressources de l'assurance maladie

Graphique 3 • Structure par branche des recettes brutes des régimes de base et du FSV en 2023



Source : DSS

Source: PLFSS 2025

Un système mixte: public et privé

Les enjeux à venir

Les défis futurs du système de santé

» La Consommation de soins et de biens médicaux

En 2023, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) s'élève à 249 milliards d'euros (8,8 % du PIB)

Composition de la CSBM		
Année 2023		
Poste de la CSBM	En milliards d'euros	En %
Soins hospitaliers	122.1	49.1
Soins ambulatoires	72.2	29.0
Biens médicaux	54.6	21.9
dont médicaments	33.4	13.4
Total	249.0	100.0
Source: DREES (2025)		

Prise en charge de la CSBM		
Année 2023		
Prise en charge par...	En milliards d'euros	En %
Sécurité Sociale	198.0	79.5
Etat	1.5	0.6
Org. Complémentaires	30.9	12.4
Ménages	18.6	7.5
Total	249.0	100.0
Source: DREES (2025)		

Si la Sécurité Sociale joue un rôle majeur dans le financement il faut noter le rôle important des organismes complémentaires et du paiement direct par les ménages (*reste à charge*).

» Si la Sécurité sociale joue un rôle central, certains types de dépenses peuvent être plus privatisés

Prise en charge de la CSBM				
Année 2023				
Composante de la CSBM	Sécurité sociale	État	Organismes complémentaires	Ménages
Soins hospitaliers	92.6	0.9	3.5	3.0
Soins de médecins et sages-femmes	73.7	0.3	17.4	8.6
Soins dentaires	39.3	0.2	43.9	16.6
Soins d'auxiliaires médicaux	80.1	0.2	11.6	8.0
Autres soins ambulatoires	84.2	0.4	12.2	3.2
Biens médicaux	63.2	0.3	21.3	15.2
Total	79.5	0.6	12.4	7.5
Source: DREES (2025)				

» Si la Sécurité sociale joue un rôle central, certains types de dépenses peuvent être plus privatisés

Hétérogénéité dans la prise en charge des soins

- la plupart des soins ne sont pris en charge qu'à hauteur de 70 % de leur tarif conventionné.
- les soins dentaires et prothèses optiques ou auditives sont particulièrement mal remboursés par la Sécurité Sociale. *Réforme du 100 % santé* (déploiement final en 2021) modifie la donne mais essentiellement à travers les complémentaires.
- les soins liés aux **affectations longue durée** (ALD) et aux **grossesses** sont remboursés à 100 % par la Sécu.
- les **hospitalisations** sont financées à 80 % par l'assurance maladie obligatoire

» Si la Sécurité sociale joue un rôle central, certains types de dépenses peuvent être plus privatisés

Focus ALD

En 2021, 14 millions de personnes (20 % de la population), étaient reconnues en ALD par l'assurance maladie (essentiellement maladies cardiovasculaires, diabètes, tumeurs et affections psychiatriques) (Source: IGF)

66 % des dépenses de la Sécu en soins s'explique par les dépenses liées aux ALD mais leur surcoût serait de 12 milliards (essentiellement du fait de l'exonération du ticket modérateur (Source: comptes de la Sécu)

⇒ grâce au dispositif ALD l'accès aux soins extrêmement coûteux ne dépend pas de la capacité des patients à payer ou à souscrire à une assurance complémentaire.

⇒ la séparation entre *petit risque* et *gros risque* permet aussi de solvabiliser les assurances privées.

» Une couverture complémentaire généralisée

Les complémentaires deviennent un acteur central du système de santé. Face à l'aversion au risque, les individus préfèrent payer une somme récurrente fixe (autour de quelques centaines d'euros) que faire face à des dépenses de plusieurs milliers d'euros à un moment inconnu.

Des complémentaires longtempths facultatives, essentielles pour les pouvoirs publics

- **Années 2000:** sous conditions de ressources l'État finance la totalité ou une partie de l'assurance complémentaire (reconnaissance implicite des manquements de l'AMO).
- **2013-2016:** un accord interprofessionnel a rendu obligatoire pour les entreprises de souscrire une complémentaire pour leurs salariés.
- **2020:** fusion des anciennes aides (CMU-Complémentaire et subventions) dans la *complémentaire santé solidaire*. Dans 90 % des cas les bénéficiaires choisissent la Sécu comme complémentaire. *Ce choix n'est pas accessible pour les autres assurés qui doivent choisir une complémentaire privée*

Les inactifs, retraités, indépendants et fonctionnaires adhèrent à une complémentaire de façon volontaire.

⇒ en 2021 96 % des français sont couverts par une complémentaire santé.

» Les acteurs de l'assurance maladie complémentaire (AMC)

3 types d'organismes

1. **Mutuelles:** gérées par leurs adhérents et l'adhésion est individuelle et volontaire. Historiquement organisées par profession ou territoire. **20 milliards de cotisations santé collectées en 2023.**
2. **Instituts de prévoyance:** organismes paritaires cogérés par les syndicats et le patronat. Ils organisent l'assurance sociale dans certaines branches ou entreprises. Souvent l'adhésion est obligatoire dans le cadre d'un accord collectif. **7 milliards**
3. **Assurances:** organismes privés à but lucratif. Adhésions privées volontaires. **15 milliards**

L'évolution du cadre réglementaire (européen) rapproche ces 3 types d'acteurs

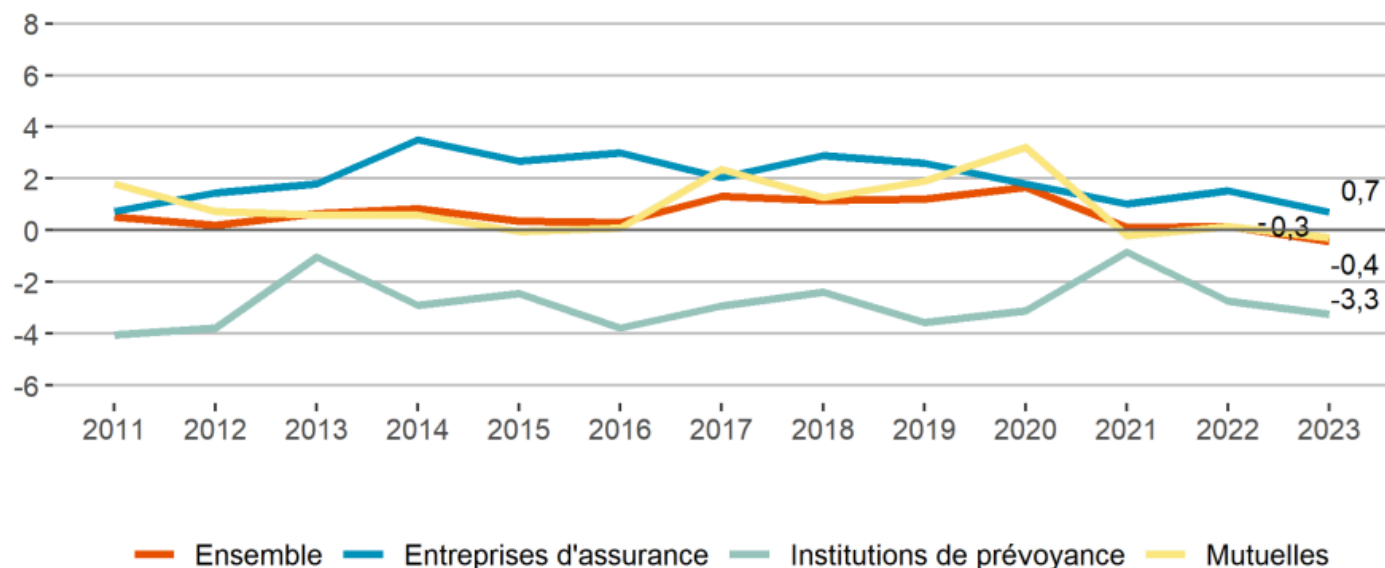
» Un secteur dans l'ensemble déficitaire

En 2023, le résultat technique est globalement déficitaire (-0,3 % des cotisations collectées). Mais où l'assurance privée reste rentable.

Si la tarification individuelle est interdite, les AMC peuvent proposer une palette de soins hétérogène et moduler la cotisation par l'âge

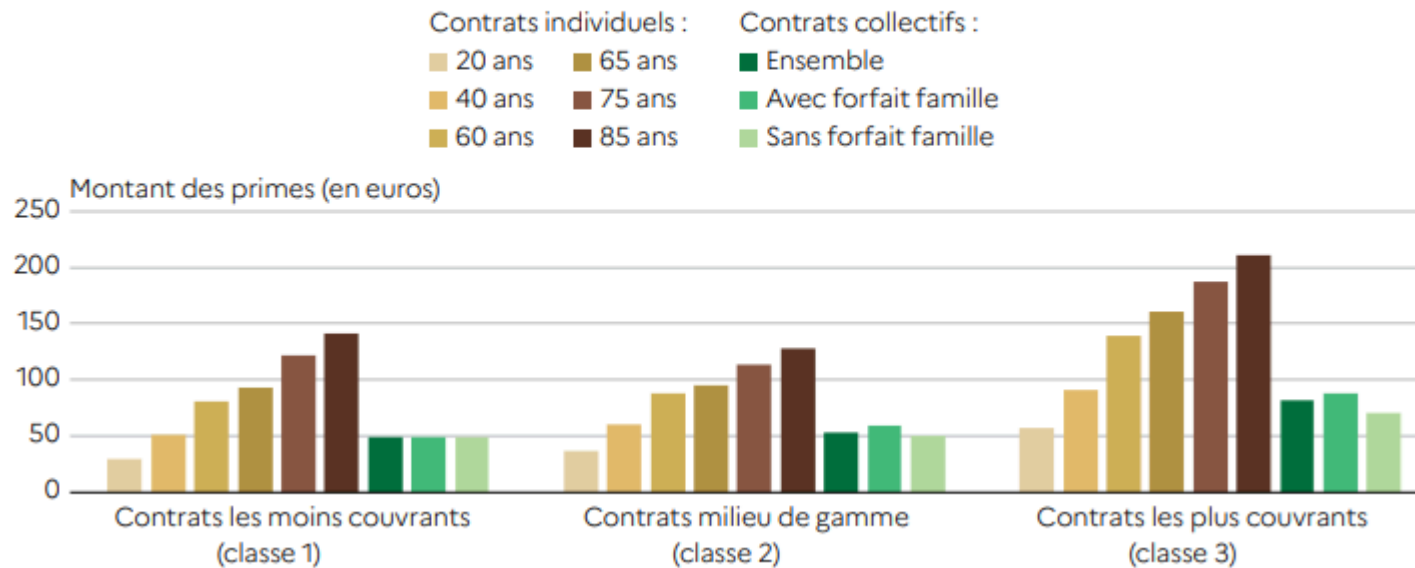
- Vous verrez que ce type de tarification peut être un *second best* et d'extraire le maximum du surplus du consommateur.

Un effet du *100 % santé* ?



» Une tarification non-linéaire

Graphique 2 Montant moyen de la prime mensuelle en fonction du niveau de couverture du contrat, en 2021



Source: DREES (2024)

» Une couverture complémentaire inégalitaire

Si l'essentiel des français a une AMC, l'étendue de l'assurance n'est pas identique.

Régulation publique

L'État définit un *panier de soins minimal* couvert par tout contrat *solidaire et responsable*. Si ce panier est assuré par l'AMC, celle-ci bénéficie d'un agrément public et d'aides.

Une réforme récente: *100 % santé*

En 2019, le gouvernement a développé le *100 % santé* dans la prise en charge de dispositifs optiques, dentaires et auditifs.

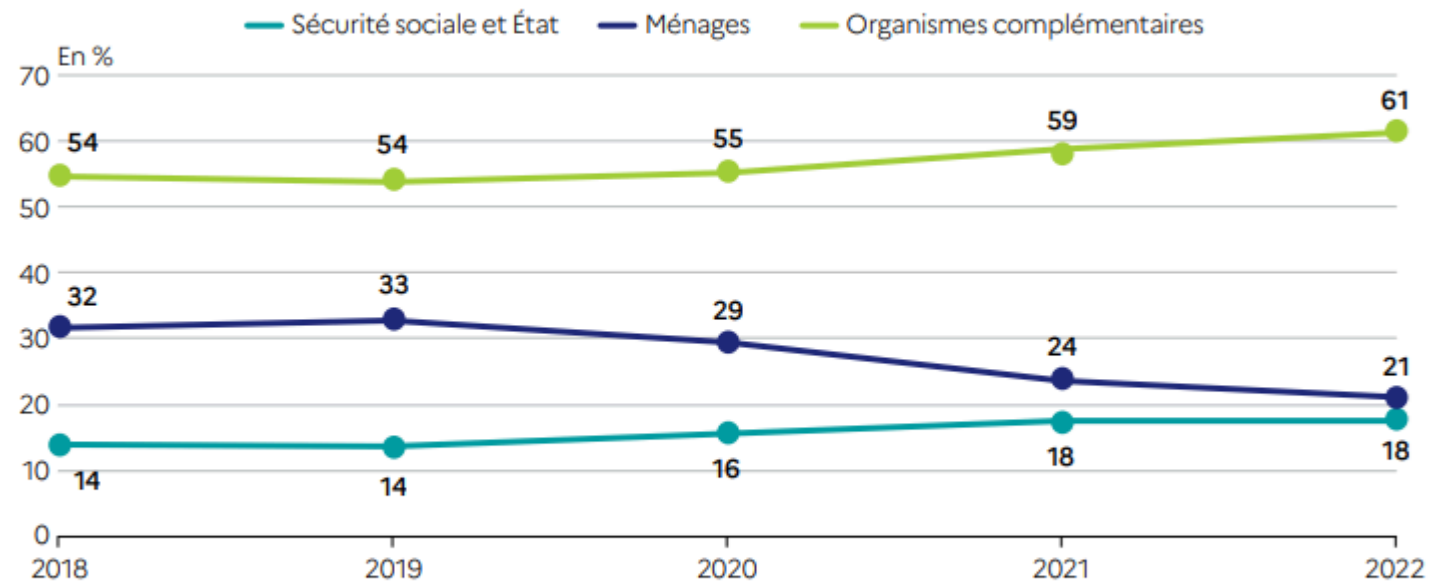
Définition de plusieurs paniers de soins qui sont remboursés à 100% et dont l'accès dépend du contrat souscrit.

Des soins couverts en fonction des préférences et la capacité à payer

Certaines dépenses courantes (*dépassements d'honoraires*) ou « de confort » (*chambres individuelles à l'hôpital*), soins paramédicaux non couverts restent à la charge des ménages et sont éventuellement couverts par des AMC qui modulent ainsi leurs tarifs selon le type de contrat.

» Effet du 100 % santé ?

Graphique 2 Part de la dépense en optique, prothèses auditives et dentaires financée par chaque acteur, entre 2018 et 2022



Note > Pour les prothèses auditives, les dépenses 2018 et 2019 des organismes complémentaires sont estimées statistiquement, les données n'ayant été récoltées qu'à partir de l'année 2020.

Lecture > En 2018, 54 % de la dépense totale en optique, prothèses auditives et dentaires était prise en charge par les organismes complémentaires, 32 % par les ménages, et 14 % par la Sécurité sociale ou l'État.

Sources > DREES, comptes de la santé.

Source: DREES (2024)

» Un problème d'efficacité consensuel

- La superposition de l'AMO et l'AMC implique que chaque dépense de santé soit traitée administrativement deux fois.
- Les frais de gestion des organismes d'AMC sont à acte identique supérieurs: moindres économies d'échelle, dépenses en marketing pour attirer des nouveaux contrats.

⇒ des frais administratifs et d'acquisitions qui pèsent 15 % des cotisations (6 milliards d'euros). Des coûts de gestion supérieurs à ceux de l'AMO!

Tableau 3 Dépenses de gestion du système de santé entre 2013 et 2023

En millions d'euros

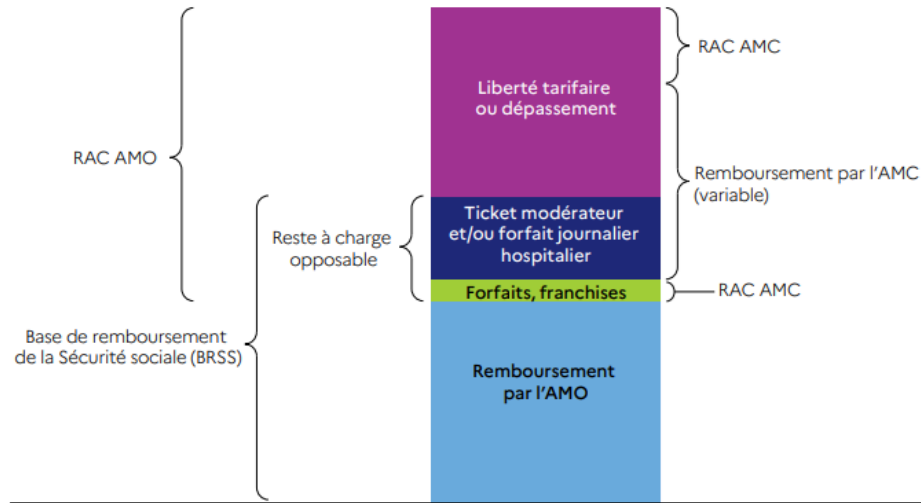
	2013	2019	2020	2021	2022	2023	Évolution 2022- 2023 (en %)
Organismes complémentaires	6 386	7 571	7 621	7 692	7 905	8 261	4,5
Mutuelles	3 320	3 639	3 696	3 687	3 775	3 874	2,6
Entreprises d'assurances	2 283	2 905	2 947	3 045	3 122	3 341	7,0
Institutions de prévoyance	784	1 027	978	960	1 008	1 046	3,8
Sécurité sociale	7 421	6 609	6 554	6 591	6 728	6 727	0,0
Administrations publiques centrales	959	991	1 003	1 118	1 058	1 102	4,2
État	831	819	824	950	902	963	6,8
Opérateurs publics	128	173	179	168	156	139	-11,0
Dépenses de gestion	14 766	15 172	15 178	15 401	15 691	16 090	2,5

Note > Les dépenses de gestion de l'État correspondent à celles du ministère chargé de la santé, tandis que celles de la Sécurité sociale correspondent aux dépenses des régimes de la Sécurité sociale (CNAM, etc.).

Source > DREES, comptes de la santé.

» Le reste à charge des ménages: 19 milliards d'euros

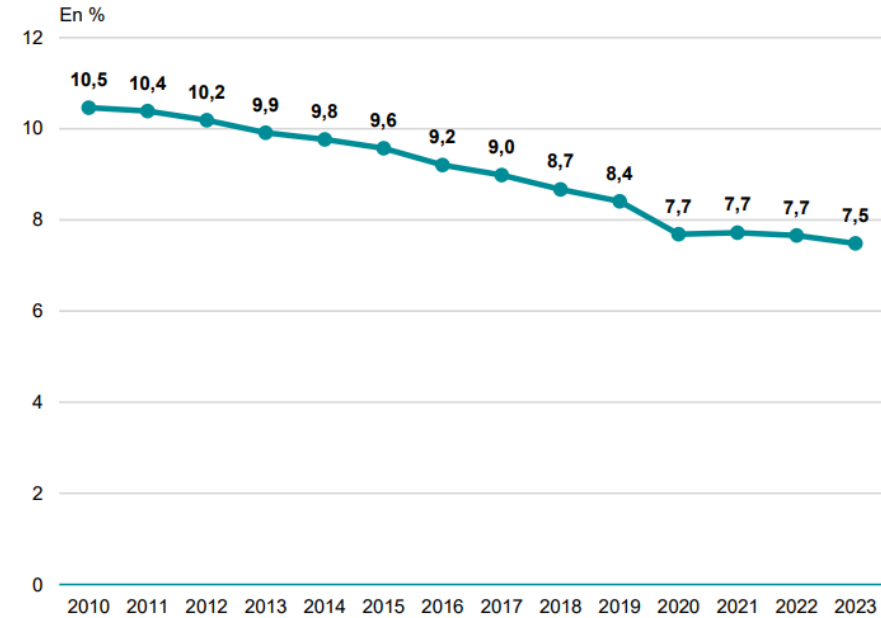
Schéma 1 Le reste à charge sur une dépense du panier de soins remboursables



AMO : assurance maladie obligatoire ; AMC : assurance maladie complémentaire ; RAC AMC : reste à charge après remboursement par l'assurance maladie complémentaire ; RAC AMO : reste à charge après remboursement par l'assurance maladie obligatoire.

Source: DREES (2024)

Graphique 1 Évolution de la part de reste à charge des ménages dans la CSBM



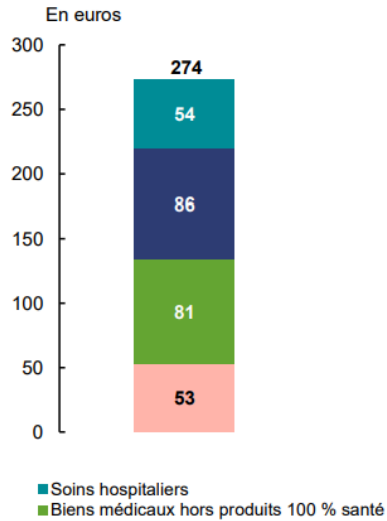
Lecture > En 2023, le reste à charge des ménages représente 7,5 % de la CSBM.
Sources > DREES, comptes de la santé.

Source: DREES (2024)

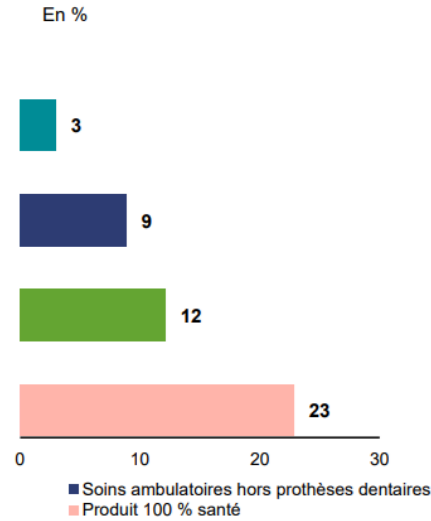
» Le reste à charge des ménages: 19 milliards d'euros

Graphique 2 Montant moyen de reste à charge par habitant et part de reste à charge par secteur en 2023

a. Reste à charge moyen par habitant

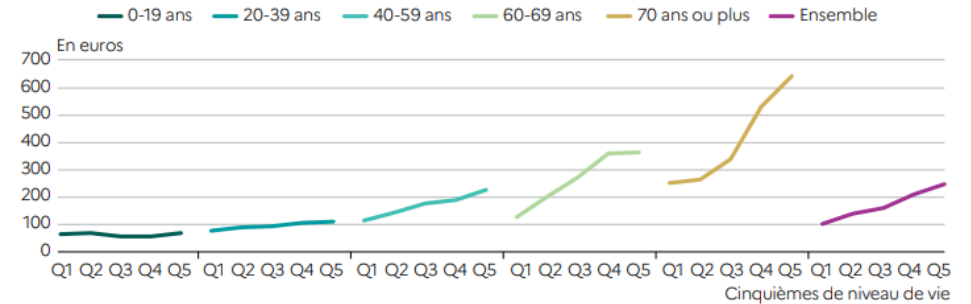


b. Part de reste à charge



Lecture > En 2023, le reste à charge des ménages représente 3 % du total de la consommation de soins hospitaliers, ce qui représente une dépense de 54 euros en moyenne par habitant.
Source > DREES, comptes de la santé.

Graphique 2 Reste à charge moyen après remboursement par l'assurance maladie complémentaire, par tranche d'âge et selon le niveau de vie, en 2019



Source: DREES (2024)

Source: DREES (2024)

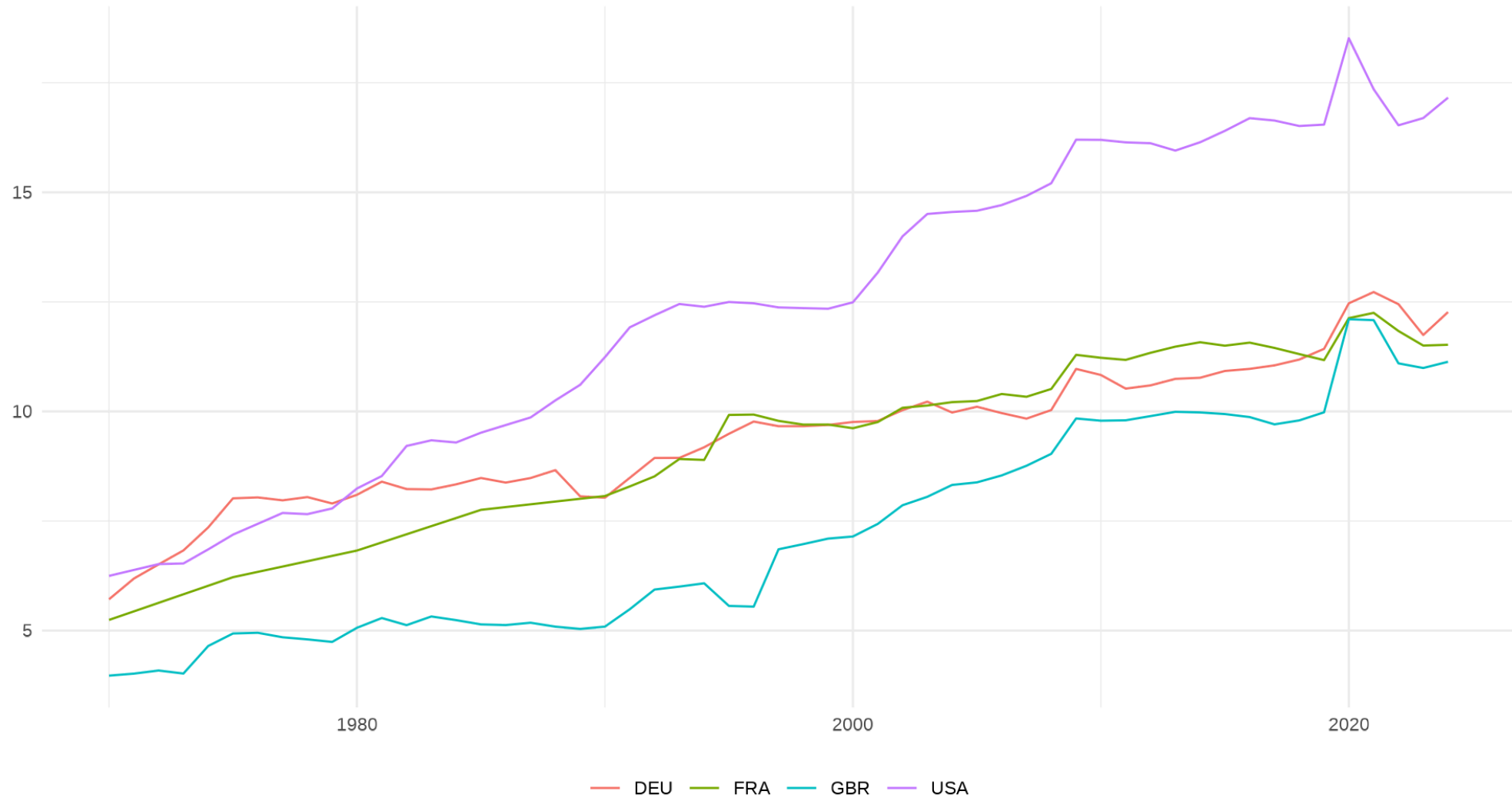
Un système mixte: public et privé

Les enjeux à venir

Les défis futurs du système de santé

» La montée tendancielle de la dépense de santé

Dépenses en santé
En pts. de PIB



Source: OCDE

» Une tendance qui n'est pas prête de se retourner

Les dépenses de santé évoluent plus vite que le PIB

1. **bien supérieur:** l'élasticité de la demande de santé de la part des ménages par rapport à leur revenu est supérieur à l'unité.
2. **vieillissement de la population:** les besoins en santé augmentent avec la démographie.
3. **évolutions technologiques du secteur:** l'assurance maladie prend en charge des dépenses de biens et services dont le prix, la quantité, la variété et la qualité évoluent en fonction de l'offre de soins, le comportements des praticiens, de la structure de marché et des technologies.

» Le solde du système de santé

D'un point de vue comptable quasiment tout le déficit du régime général de la Sécu s'explique par la santé

Soldes par branche des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale				
Soldes (en Mds)	2021	2022	2023	2024
Maladie	-26.1	-21.0	-11.1	-13.8
AT-MP	1.3	1.7	1.4	0.7
Vieillesse	-1.1	-3.9	-2.6	-5.6
Famille	2.9	1.9	1.0	1.1
Autonomie	0.3	0.2	-0.6	1.3
Régimes de base	-23.0	-21.0	-11.9	-16.4
FSV	-1.5	1.3	1.1	1.1
RB + FSV	-24.5	-19.7	-10.8	-15.3
Source: MTSSF				

» Le solde du système de santé dans le futur

Table 5: **Baseline – expenditure projections**

	2024 Ageing Report					
	pensions			health care		
	2022	Δ 2022-45	Δ 2022-70	2022	Δ 2022-45	Δ 2022-70
BE	12.7	1.9	3.5	6.1	0.4	0.6
BG	9.5	-0.1	0.1	4.5	0.4	0.2
CZ	8.7	1.3	1.7	6.4	0.1	0.2
DK	8.3	0.0	-1.4	7.4	0.1	0.4
DE	10.2	0.8	1.2	8.0	0.0	0.1
EE	7.4	0.1	-0.7	5.1	0.4	0.6
IE	3.8	1.7	2.8	4.1	0.8	1.5
EL	14.5	-0.5	-2.5	5.4	0.6	0.6
ES	13.1	3.8	3.6	5.9	1.0	1.2
FR	14.4	-0.5	-0.9	8.8	0.1	0.3
HR	9.0	0.3	-0.2	5.8	0.4	0.7
IT	15.6	0.9	-1.9	6.3	0.1	0.1
CY	8.2	2.7	3.6	7.5	0.5	0.8
LV	7.2	-0.8	-1.7	6.0	-0.3	-0.3
LT	6.4	3.1	3.2	4.3	0.5	0.8
LU	9.2	2.6	8.3	3.9	0.7	1.2
HU	7.7	2.4	4.3	4.3	0.4	0.5
MT	6.2	-0.5	4.4	5.1	0.5	2.1
NL	6.5	1.4	2.0	5.7	0.5	0.7
AT	13.7	0.5	0.4	7.8	0.8	1.1
PL	10.2	0.4	-0.2	4.4	0.7	1.1
PT	12.2	2.9	-1.8	6.2	0.7	1.0
RO	8.5	2.1	-0.9	4.4	0.6	0.7
SI	9.8	3.0	3.8	7.0	0.7	0.8
SK	8.5	2.7	2.8	5.7	1.3	1.6
FI	12.8	-0.4	1.4	6.2	0.4	0.6
SE	7.4	-0.4	-0.2	7.3	0.1	0.4
NO	10.8	1.2	1.7	7.7	0.8	1.2
EA	11.9	0.9	0.6	7.1	0.2	0.4
EU	11.4	0.7	0.4	6.9	0.2	0.4

Source: European Commission, EPC.

» Un détour: 2 logiques de mesures des économies budgétaires

2 méthodes:

1. Écart par rapport à la croissance potentielle (**effet sur le solde structurel**)
2. Écart par rapport à la tendance spontanée de la dépense

Besoin du calcul de la tendance de la dépense publique

Si la dépense en santé évolue spontanément plus vite que le PIB alors faire évoluer celle-ci comme le PIB (nominal ou potentiel) revient à contraindre l'offre en santé par rapport à la demande, spontanée des ménages.

⇒ dans ce contexte le gouvernement fait un effort pour freiner la dépense.

On calcule l'effort en dépenses de la suivante façon:

$$\text{Effort en dépenses} = \frac{\text{Dépense}}{PIB} \times \left(\frac{\Delta \text{Dépense}}{\text{Dépense}} - g \right)$$

où g est soit la croissance potentielle potentielle en valeur, soit l'évolution spontanée de la dépense publique.

La 1^{ère} logique a plus du sens pour parler de stabilisation de la dette et de pilotage conjoncturel et la 2^e a une logique de politique économique et de finances publiques.

⇒ actuellement le gouvernement a tendance à communiquer au public avec la 2^e logique, sans expliciter la méthodologie pour calculer g . Voir [Sampognaro \(2015\)](#).

» Un pilotage de l'État de plus en plus présent: l'Ondam

Le vote annuel du PLFSS est l'occasion de voter l'Ondam:

L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) est un objectif de dépenses à ne pas dépasser en matière de soins de ville et d'hospitalisation dispensés dans les établissements privés ou publics, mais aussi dans les centres médico-sociaux.

Il a été créé en 1996 à la suite du *Plan Juppé*. Il correspond aux objectifs des dépenses de la sécurité sociale :

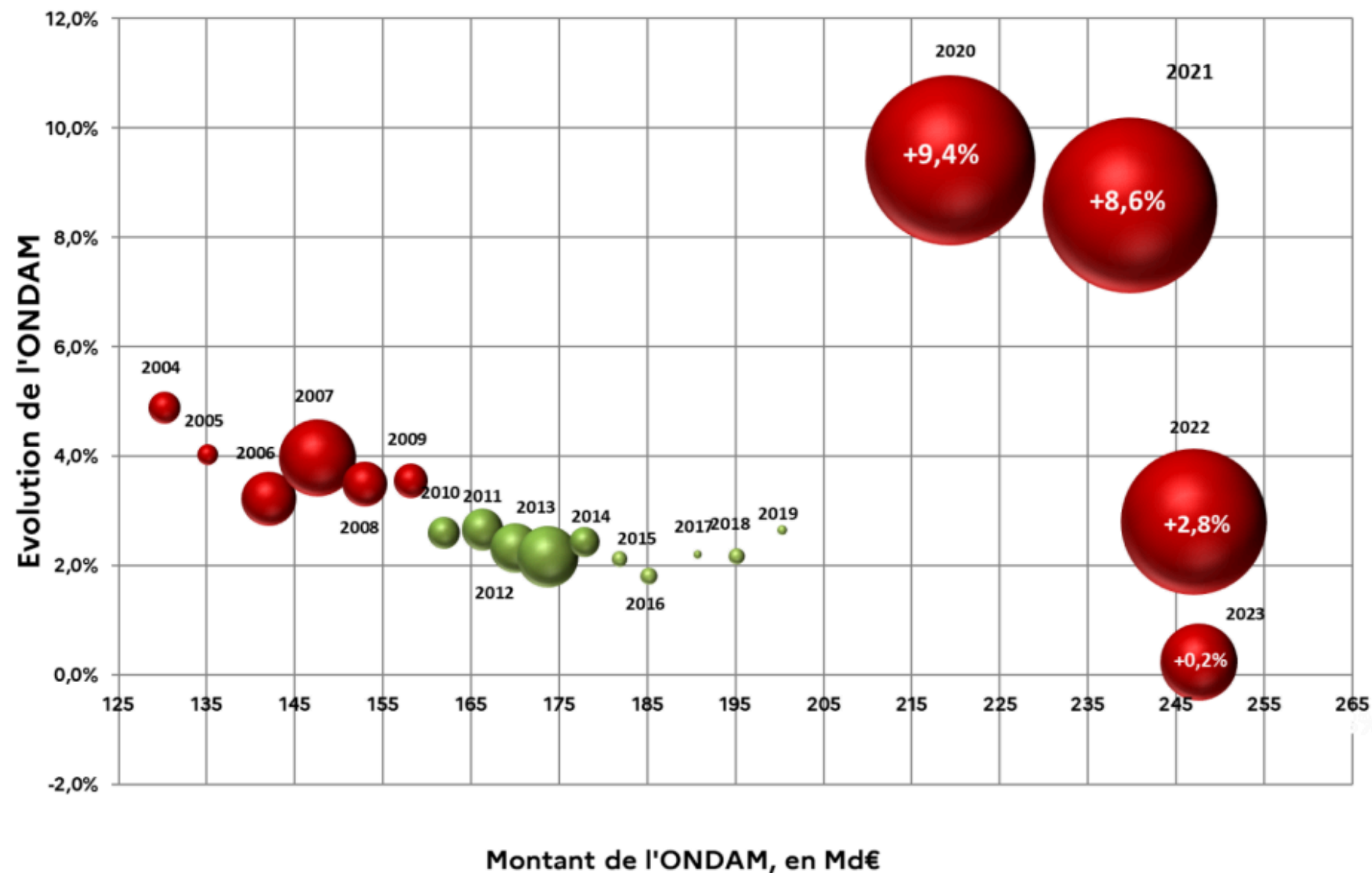
- les soins de ville,
- les établissements de santé publics et privés,
- les établissements médico-sociaux,
- les autres prises en charge

Ces dépenses représentent (actuellement) 8,7 pts du PIB.

⇒ il s'agit d'un objectif et non d'une limite de la dépense comme dans la dépense de l'Etat dans le PLF!

» Un objectif tenu depuis la crise de la zone euro

Graphique 3 – Evolution dans le champ de l'ONDAM depuis 2004



Note de lecture : en abscisses figure le niveau de dépenses constaté en milliards d'euro et en ordonnées le taux d'évolution associé (depuis 2020, y compris dépenses covid) ; la taille de la bulle représente l'ampleur du dépassement (en rouge) ou de la sous-exécution (en vert), par rapport à l'ONDAM voté en LFSS de l'année. Ainsi, en 2023, les dépenses totales dans le champ de l'ONDAM atteignent 247,6 Md€, soit une évolution à périmètre constant de 0,2%.

» Des dispositifs d'incitation financière contre la surconsommation

Le principe du co-paiement

Pour éviter l'*aléa moral* depuis le 19^e siècle chaque personne doit prendre en charge une part du prix des biens et services de santé.

Un individu est ainsi moins incité à *sur-solliciter* la protection de l'assurance.

Alea moral

L'aléa moral décrit une situation d'asymétrie d'information où une partie n'observe pas parfaitement les actions entreprises par l'autre partie.

Un effet pervers qui peut apparaître dans ce type de situations est qu'un agent, isolé d'un risque, se comporte autrement que s'il était totalement lui-même exposé au risque.

La théorie des contrats et la théorie des incitations étudient cette asymétrie d'information dans les relations entre agents économiques.

Wikipedia

» Des dispositifs d'incitation financière contre la surconsommation (2)

Soins

Des dispositifs qui s'accumulent:

1. **Ticket modérateur**
2. **Forfait hospitalier**
3. **Franchises médicales:** pour éviter que les AMC compensent le ticket modérateur, il a été décidé qu'une partie de ces tickets ne pouvaient pas être remboursés.
4. **Participation forfaitaire**

Indemnités journalières

1. Remboursement de 50 % des IJ
2. Jours de carence

Renoncements aux soins

Entre 8 et 19 % des individus renoncent à des soins (parmi les 20 % les plus pauvres cela va de 13 à 30 %). (Source: DREES)

» La régulation par les prix

Pour réguler les actes la Sécurité Sociale peut agir à travers les **tarifs** (consultations, prix des médicaments, des actes médicaux).

Ces tarifs sont négociés avec les professionnels et servent de base aux remboursements.

Ces tarifs peuvent correspondre ou pas à la réalité des coûts

Quand la tension est forte la Sécu doit revaloriser ses tarifs ou autoriser les producteurs à pratiquer des honoraires libres (depuis 1980 les médecins de secteur 2 peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires).

Les dépassements d'honoraires expliquent l'importance des AMC

Risque: développement des assurances dans un marché où les producteurs de soins sont libres de fixer leurs prix peut avoir des effets inflationnistes comme aux Etats-Unis

» La régulation par l'offre de soins

Hors hôpital public, une grande part de l'offre de soins est réalisée par des acteurs privés. La puissance publique tente de réguler l'offre.

Médecine de ville: en salarisation croissante

- Au 1^{er} janvier 2025, 42 % des médecins exercent en libéraux « purs ». Une tendance à la hausse à la salarisation de la profession (hôpital, établissements de soins publics ou privés, regroupements de type *maison de santé*).
- En 2022, 83 % des infirmi.er.ère.s sont aussi salarié.e.s

Les pouvoirs publics tentent de réguler l'offre sans remettre en cause la liberté d'installation des médecins libéraux ni le libre choix du médecin par le patient:

- médecin traitant (2/3 des généralistes déclarent être amenés à refuser de nouveaux patients comme médecin traitant) et les consultations chez les spécialistes ne sont remboursées que si le patient est dans un *parcours de soin*.
- création des ARS en 2008.

» La régulation par l'offre de soins: l'hôpital public

Rôle central des hôpitaux

1. moitié des soins sont produits à l'hôpital
2. formation des médecins

Maîtrise de l'activité à travers les *New public management*

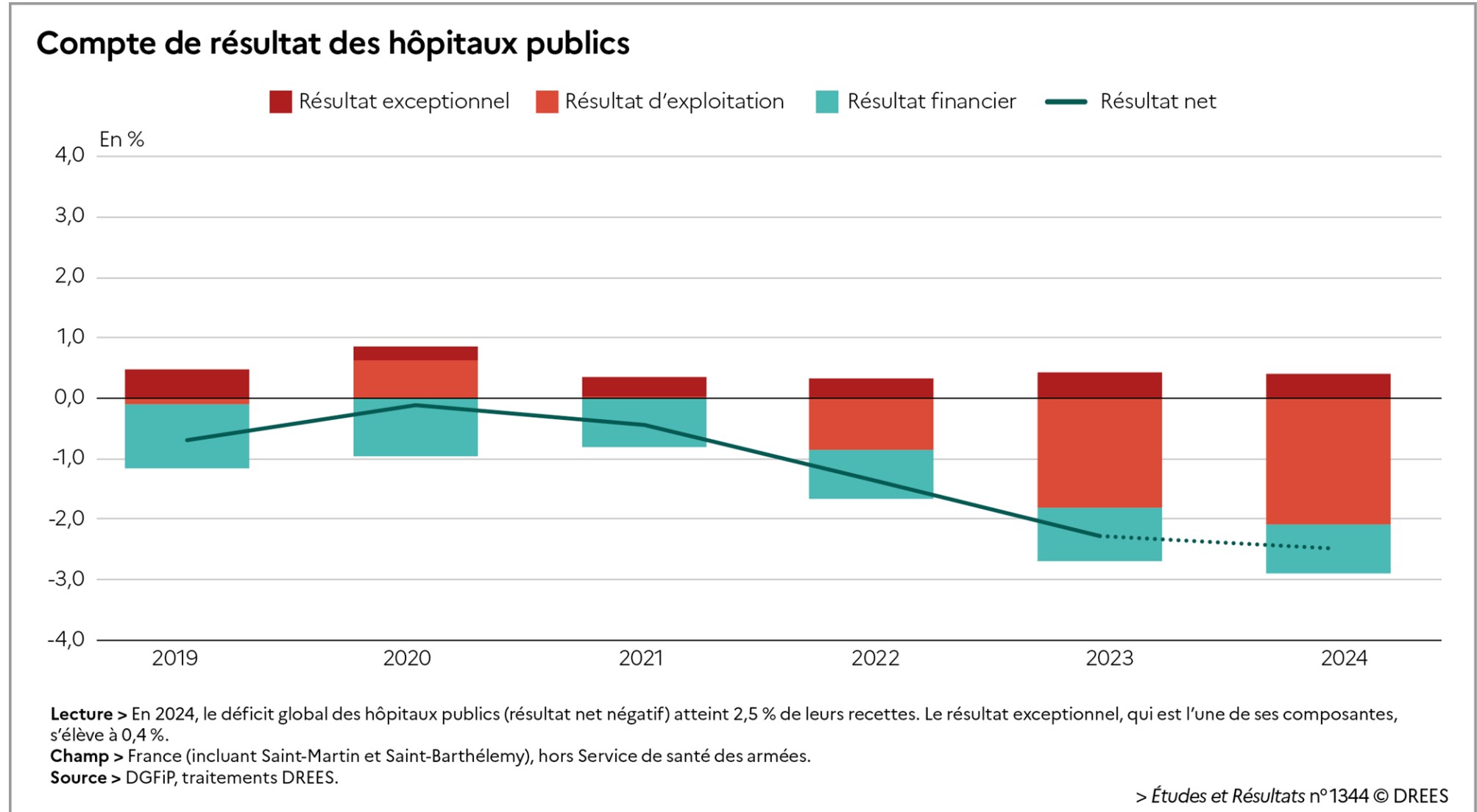
- Années 1990: gestion faite sur des indicateurs de performance qui tentent de mimer un comportement marchand.
- 2000: tarification à l'activité (T2A). Les subventions de la Sécurité Sociale aux hôpitaux faite sur la base des actes et non d'une enveloppe globale.
- Virage ambulatoire de l'hôpital: fermeture de 43000 lits d'hospitalisation complète en 10 ans (-11 %) compensées, partiellement, par 21000 lits d'hospitalisation partielle.
(DREES)

Problèmes majeurs:

1. Inadéquation des tarifs fixés
2. Lourdeurs administratives

⇒ Incitation à optimiser l'activité en fonction des contraintes financières. Les cliniques privées sur les actes rentables et les hôpitaux publics sur les actes déficitaires.

» La crise de l'hôpital public



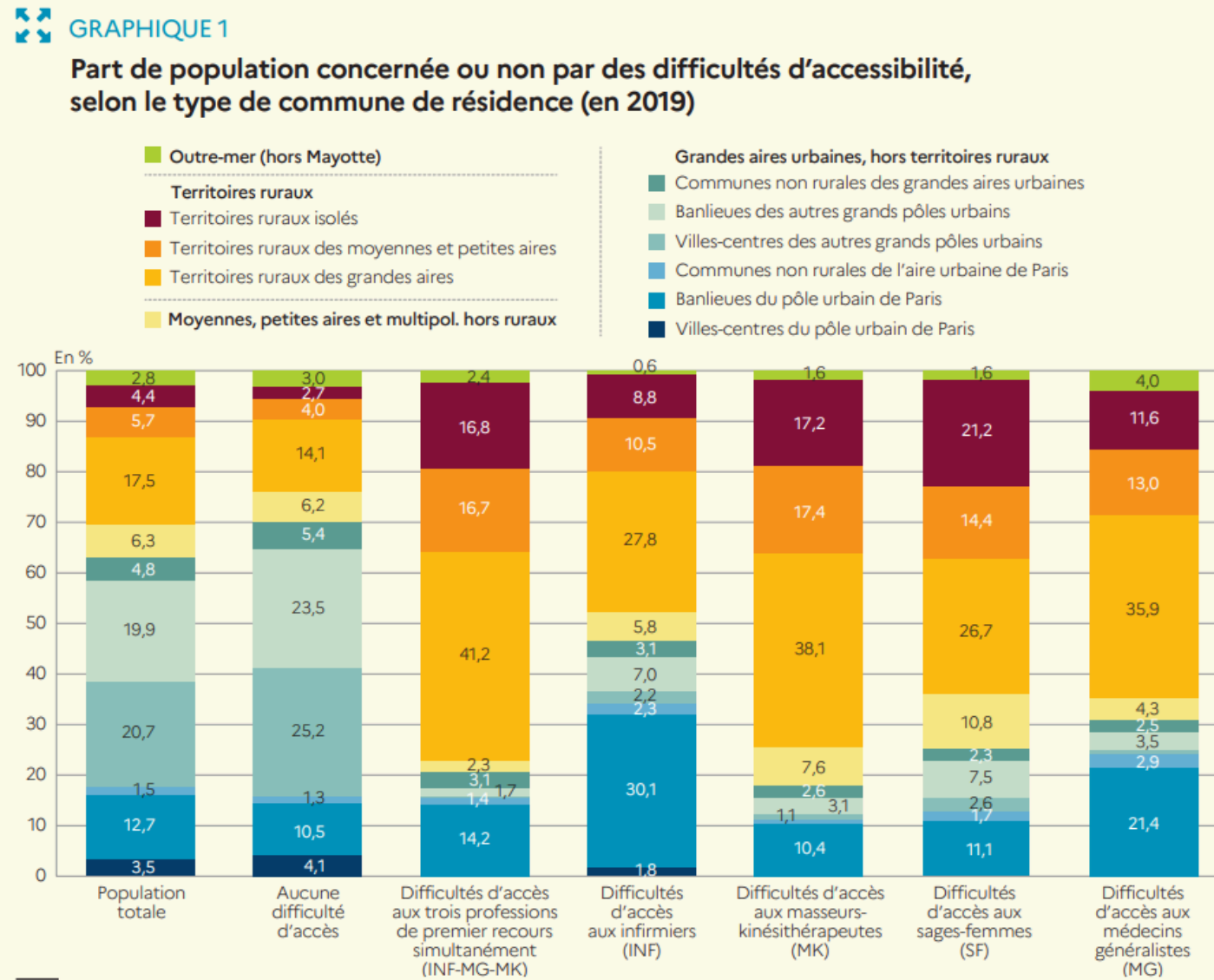
Source: DREES (2025)

Un système mixte: public et privé

Les enjeux à venir

Les défis futurs du système de santé

» Les enjeux à venir: les inégalités territoriales



» Les enjeux à venir: *la Grande Sécu*

Le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) a publié un rapport proposant une *Grande Sécu* qui intègre ou articule l'AMO et les AMC.

4 *scénarii étudiés*

1. Améliorer les articulations entre AMO et AMC sans changer la structure actuelle en suivant l'exemple du *100 % santé*
2. Une assurance complémentaire obligatoire, universelle et mutualisée. *La question de la tarification de l'AMC obligatoire n'est pas banale*
3. Augmentation des taux de remboursement de la Sécurité sociale
4. Décroisement entre les domaines d'intervention de la Sécurité sociale et des assurances complémentaires. *Scénario de rupture. L'AMC ne se limite pas à compléter l'AMO mais chaque assurance doit se concentrer sur un panier de soins différent. L'AMO sur le « gros risque » et les AMC en concurrence sur le « petit risque ».*

» Un défi de société: la dépendance

- Prévalence de 20 % chez les 85 ans et plus.
- Avec le vieillissement de la population, ce risque se situe à la frontière des risque santé et vieillesse. Ce risque aura tendance à s'accroître dans le futur.
- Il occasionne des besoins de prise en charge et d'accompagnement difficilement anticipables par les personnes (et leurs familles)

Deux situations différentes

1. Résidant en logement privé, nécessitant de beaucoup de soins à domicile
2. Résidant en EHPAD

Situation actuelle: deux politiques publiques

1. **Allocation personnalisée de dépendance (APA):** calculée en fonction du degré de dépendance et des ressources. Elle finance une partie des heures d'aide à domicile (sur la base d'un tarif conventionné par département).
2. **Crédits d'impôts:** le reste à charge bénéficie d'un crédit d'impôt (50 % pour l'aide à domicile et 25 % en EHPAD)

⇒ situation paradoxale les personnes dépendantes à faible ressource, non imposables ne bénéficient pas des crédits d'impôts.

» Un défi de société: la dépendance

Pour une 5^e branche de la Sécurité Sociale

Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) avait estimé le montant des besoins supplémentaires à financer à 13 milliards d'euros d'ici 2030 : 6 Md€ pour le maintien à domicile et 7 Md€ pour les Ehpad (**source: CESE**)

» La semaine prochaine

Thème: La fiscalité des ménages: la taxation des revenus

Sources

Gruber: Chapitres 20 et 21 (5^e édition).

Bénassy-Queré, Coeuré, Jacquet et Pisani-Ferry: Chapitre 7 (3^e édition).

Rapport

CPO (2024), *Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus*